

督導的歷程：同盟、人際技能、個案概念化與介入技能

對應原書：Greenberg, L. S., & Tomescu, L. R. (2017). *Supervision Essentials for Emotion-Focused Therapy*. APA. 第3章 The Process of Supervision (pp. 45–79) 本檔內容：學習目標 | 完整學術摘要 | 核心概念洞見 | 關鍵原文引述 | 臨床推理框架

標示說明：「原教材指出」表示內容直接來自原書；「從臨床實務角度」表示本教材的延伸詮釋。原書的督導示例取自真實督導錄影，已由作者改寫以保密；本教材只摘述其教學重點，不逐字重製逐字稿。

本單元學習目標

完成本單元後，你能夠：

1. 能區分同理理解、同理肯定、喚起性、探索性回應與同理臆測，並針對同一句個案陳述各寫出一則回應，符合「最多領先一步」原則。〔創造／介入〕
2. 能依兩階段、十一步驟的 EFT 概念化，從個案資料中追隨「痛苦羅盤」，暫定核心情緒自我組織（羞愧／焦慮不安全／悲傷孤單），並列出支持與反駁的資料。〔分析／概念化〕
3. 能辨認逐字描述中個案的聲音品質（聚焦型、外化型、受限型、情緒型），並判斷情緒生產性七向度中哪些尚未達成。〔分析／評估〕
4. 能將個案語句對應到七種任務標記，選擇相應的介入並說明解決的樣貌，同時判斷「此時是否適合介入」。〔應用／介入〕
5. 能在雙椅或空椅片段中，指出治療師偏離任務結構之處（滑成討論、開放提問引出辯護、為逃避而調節），並寫出修正回應。〔評鑑／介入〕
6. 能說明情性知識與程序性知識的差別，並規劃一個以錄影片段為基礎的知覺技能練習。〔創造／反思實務〕
7. 能追蹤一個跨多次晤談的個案，隨新資料更新概念化（焦慮分裂→未竟事務→自我中斷），並把拒斥性憤怒改寫為「我」語言的賦能性憤怒。〔分析／概念化〕
8. 能說明督導同盟三成分，以及同盟品質如何影響受督者對回饋的接受度。〔理解／治療關係〕

§2 完整學術摘要

A. 主題與背景

原教材指出，督導歷程有三個主要焦點，本章依序處理：

1. 督導同盟；

2. 受督者的人際技能：與同盟形成、在場，以及達成核心治療條件（無條件正向關懷、真誠與同理）有關的技能；
3. 受督者的技術技能：個案概念化與介入技能。

本章以同一位個案在不同時間點的督導為例作結，讓讀者看到督導如何隨治療推進。

為什麼這是全書的核心章節（從臨床實務角度）：前兩章提供理論與結構，本章則是 EFT 督導實際在教什麼：如何在場、如何同理、如何概念化、如何聽見聲音與情緒的變化、如何在標記出現時進入任務。對碩士生來說，這幾乎就是 EFT 臨床能力的完整清單。

B. 督導同盟

B1. 同盟是督導的第一個任務

原教材指出，督導者與受督者之間的同盟形成，可以理解為最初的督導任務，因為這是督導開始或失敗的地方。任何人與人的相遇都從接觸開始；EFT 治療與督導最初的焦點，是建立「先接觸，再訂契約」（Gendlin & Beebe, 1968）。作者強烈認為，督導者需要與受督者建立溫暖、同理、驗證性的連結；督導者必須在場、活在當下，並回應受督者的感受與需要。在這個基礎上，才能建立對督導目標與任務的合作。

B2. Bordin 的督導同盟三成分

依 Bordin (1983)，督導同盟包含：

成分	內容	原書舉例
(a) 強烈的情感連結	關係的溫暖與依附	—
(b) 對督導目標的共識	雙方同意要達成什麼	熟練特定的治療技能、擴展概念化能力
(c) 督導任務被認為有關聯	受督者認為督導中做的事與目標相關	用同理探索或角色扮演，而不是講授，來解決某個議題

這個觀念把關係的溫暖與依附（連結）與合作（任務與工作面）結合在一起。

B3. 同盟是本模式的中心支柱

- 在督導開始時發展強的工作同盟，被認為對督導的品質與結果很重要。它是整個督導歷程的基礎，包括辨識督導標記、提供促進性的任務環境、受督者的改變歷程，以及解決帶進督導的議題。
- 同盟是共同建構的，但督導者因其專業與角色，負有促進與維持同盟的主要責任。
- 同盟的形成，受到與任何治療同盟相同的個人與專業因素影響。Falender 與 Shafranske (2004) 指出，受到高度評價的督導者特質包括：同理、不評判的態度、給予驗證或肯定、接納的態度、鼓勵探索與嘗試、正直、給予自主，以及體諒。此外，在場、真誠、溫暖、同理與情緒投入的能力，也支持連結的發展 (Geller & Greenberg, 2011)。
- 同盟與回饋的關係：強的督導同盟，是協助受督者發展同理探索技能所必需的。同盟不只為受督者提供安全基地，也提供穩定的基礎，讓督導者能提出替代的、更同理的回應方式。有了好的同盟，受督者較能接受回饋，也較不會覺得建設性批評具有威脅性或令人羞恥。

B4. 與個案建立同盟：目標共識是同理的展現

原教材指出，助人關係的另一個重要面向，是透過在治療目標與任務上合作來建立同盟，讓雙方感到一起在克服問題。取得目標與任務的共識，取決於理解個案，以及什麼對個案有幫助，因此它本身就是同理的展現。在 EFT 中，目標共識通常是這樣達成的：捕捉個案長期掙扎的痛苦，並同意一起處理這份痛苦，而不是設定一個行為改變目標。督導者引導受督者取得對主要目標的共識。

C. 人際技能：在場與核心條件

C1. 兩類人際技能

原教材指出，受督者需要發展：

- 關係的技能：與個案形成並維持強的治療同盟；
- 存在的技能：在場並且同理，也就是活在當下、同理地調頻情感、向個案傳達同理，並以敏感的方式回應。

這能營造溫暖、驗證的氛圍，邀請個案探索自己與生活，並合作處理目標與任務。這裡需要許多知覺技能，因為它們是回應與情感調頻的基礎；而治療性在場則是知覺此時此地發生什麼的前提。

C2. 治療性在場

- 地位：Geller 與 Greenberg (2011) 認為，治療師的在場是調頻與回應的前提。在場讓人能以特定方式感覺、觀看與傾聽個案，進而做出與個案此刻調頻的回應。為了促進這種回應，督導者持續協助受督者看見非語言上發生的事，並加以回應。
- 定義：把整個自己帶進與個案的相遇，在多個層次上完全處在當下：身體、情緒、認知與靈性。治療性在場是完全沉浸於當下，不帶評判或預期，與個案同在，也為個案而在。這是治療師的一種特定存在方式。
- 發展順序：在專業發展初期，年輕治療師首先被鼓勵透過觀察與傾聽個案的逐刻歷程來變得在場。在督導中，受督者進一步學習如何協助個案辨識並符號化自己的經驗、反思它，並以新的方式理解它。
- 目標：EFT 督導的目標是發展受督者高度的同理調頻。好的 EFT 治療師隨時回應地調頻於個案敘事中的所有細微差異與隱含意義，也調頻於當下的治療關係。要完全回應，治療師需要學會仔細聽、清楚看，並與個案的生命故事、當前擔憂與晤談中的處理風格共鳴，才能主動與個案對話，並整合情緒與理性、過去與現在、需求與價值等不同面向。

C3. 同理的類型

原教材指出，EFT 督導的主要目標，是讓受督者能夠有成效地進行同理探索這個基礎任務。這需要受督者能注意個案的經驗，並探索、符號化個案的感受與意義。治療師需要從在場與同理開始，這能幫助個案轉向內在、深化經驗。治療師需要使用不同類型的同理 (Greenberg & Elliott, 1997)：

類型	功能	督導中的重點
同理理解	傳達對個案經驗的理解，並核對理解；是基礎任務	督導者反覆指出：同理理解是提煉並傳達個案溝通的精髓，不是要推動探索或提高喚起；它是跟隨個案敘事、保持在場與回應、傳達理解

類型	功能	督導中的重點
同理肯定	肯定並確認個案的經驗	屬於同理的一種形式（見第3節「脆弱」標記）
探索性同理：喚起性回應	喚起、使經驗鮮活	—
探索性同理：探索性回應	聚焦於個案經驗的前緣，使內隱變成外顯；是 EFT 督導中同理介入的基本模式	回應若以個案陳述中最鮮活之處收尾，個案的注意力就會聚焦在那裡，進而分化經驗的前緣
探索性同理：同理臆測	對個案感受的猜測或預感，或建議個案試說的語句；明確來自治療師的參照架構	不同於停留在個案參照架構內的探索性回應。例如「我想像你感覺……」「我的預感是……」。特別有助於讓理智化的個案停留在感受上

C4. 原書督導示例的教學重點

原書以數段督導錄影（部分來自配套 DVD）示範同理技能的督導。本教材摘述其教學重點：

1. 跟隨前緣（個案在空椅中面對母親）：個案說出好幾種感受，其中包括「我愛你」，也說母親身上有些東西讓他覺得「毛骨悚然」。督導者指出：對一位偏理性的個案而言，他說出了相當多感受；說「我愛你」時，也許可以放大（「再說一次」）；但現在出現了「毛骨悚然」，這是很強的字眼，值得反映並探索。要點：督導者辨識出個案經驗的前緣，協助受督者反映最觸動之處，並把個案的注意力引向內在。
2. 被確認的同理臆測：治療師猜測個案害怕：「如果離開，可能就是唯一的機會了。」個案說：「對，我真的這樣覺得。」督導者肯定這是很好的同理臆測：個案並沒有說出來，但治療師感覺進去，抓到了「我很害怕」的精髓。
3. 從外在到內在，並停留（「好孩子」片段）：這一段可以拆成六個時間點：
4. 個案聽到母親希望他當個好孩子，只說「聽到這個會很有意思」，同時手指在敲打。督導者說，這在歷程上是「危險的」，因為「有意思」停留在外面；敲打顯示他開始被活化、激動起來。
5. 治療師說「你看起來其實有點難過」，督導者肯定這是轉向情感軌道，使用了臆測或觀察，能把個案的注意力帶向內在。
6. 個案說那些期待與限制窄化了他本來可能成為的人。治療師說「停留在那個感覺」，督導者肯定：個案的聲音變得更聚焦、更內在，治療師把他留住，沒有讓他跳出去解釋；「窄化」是一種體會到的意義。
7. 個案深吸一口氣，指出感受位在身體的太陽神經叢處。
8. 個案說「我覺得……被剝奪了」，接著說「但我覺得……」，開始轉向意義敘事。督導者指出這是關鍵時刻：「被剝奪」是核心，應該幾乎打斷地引導：「就是被剝奪。」
9. 對理智型處理者，這時用同理臆測特別有幫助：進入你對他的了解，推測他一定感受到什麼，例如「就是被剝奪，你有好多需要、想表達的自己……像被從膝蓋砍斷」，展開內在經驗，把他的注意力拉回來。督導者的結語是：你做得很好，只是可以更貼近。

C5. 平衡探索性同理與同理理解；近側發展區

- 督導者也需要提醒受督者：探索性同理必須與同理理解平衡。同理理解帶來被理解的感覺，提供安全、接納與驗證的框架。
- 整體而言，督導者引導受督者做出聚焦於成長導向可能性的同理回應，這些可能性正在個案身上浮現，或隱含在個案的經驗中；但回應也要保持在個案的近側發展區內，聚焦於個案伸手可及的可能性。
- 治療師不能太超前，也不能太落後。同理回應最多可以領先一步，足夠接近個案所在之處，作為個案走出痛苦狀態的踏腳石。領先兩步，也就是離個案經驗太遠、跳得太快，可能讓個案難以跟上。落後於個案，則可能造成阻礙。

C6. 正向關懷與真誠

- 除了不同形式的同理，正向關懷與真誠也是督導中會處理與檢視的關係特質。
- 督導者引導受督者以有紀律的方式接納與一致，方法是在看錄影時討論如何做到，並示範回應。
- 整體目標是接納個案的所有經驗，傳達一種珍視的態度：重視個案，不帶評判地接納他。
- 受督者透過聆聽與討論自己晤談中的相關事件學到：個案與治療師之間真誠的關係及其恆定性，為個案提供了矯正性情緒經驗。
- 真誠是處理關係議題的關鍵（第4章詳述）。

D. 個案概念化的督導

D1. 概念化始於情緒痛苦

- 治療師與個案形成安全信任的關係，個案也能自在地揭露相關情緒資訊之後，關係開始穩固，敘事也開始展開。督導者這時引導受督者聚焦於聽見個案如何處理情緒、建構意義，以及個案的情緒處理風格如何促進或阻礙他取用內在經驗。
- EFT 概念化首先聚焦於個案的情緒痛苦（Goldman & Greenberg, 2015）。個案表達痛苦的特定方式，以及他對治療師回應的反應，是引導介入的依據。

D2. 痛苦羅盤

原書中，督導者對受督者說明（此處為改寫整理）：若能追隨個案展現的那份很觸動的悲傷，就會帶我們到核心；在個案概念化中，我們說「跟著痛苦羅盤走」。痛苦像一個羅盤，會帶你到核心所在，所以你必須跟隨歷程。在追隨個案的痛苦並抵達之前，我們無法說出核心是什麼。

與其他概念化取向的區分：原教材指出，督導者不是鼓勵受督者描繪個案持久的人格、性格動力、防衛、核心信念，或跨時間重複的關係模式，而是鼓勵受督者追隨個案的痛苦，讓痛苦作為羅盤，引導他們抵達個案的核心困難。

D3. 核心情緒自我組織

- 定義：受督者被鼓勵去感覺個案以情緒為基礎的核心自我組織。這個自我組織以痛苦的、原發的、非適應性的情緒基模為基礎，讓人理解個案最穩定、最持久的問題自我狀態。這份理解來自追隨個案的痛苦。

- 三種典型的核心理組織：

核心理組織	原教材的描述
焦慮不安全	核心上基本不安全，源於核心的焦慮感受；無法獨處
悲傷的孤單被遺棄	伴隨遺棄恐懼的核心悲傷；孤單被遺棄的感受
羞愧	基於核心羞愧而覺得不足、沒有價值

也可能是這些的特殊組合。 - 依據現象學經驗：這些自我組織與情緒的辨識，依據的是個案的現象學經驗，而不是對假設性潛在原因的詮釋或推論。 - 功能：對情感的同理調頻讓個案感到安全、被驗證，並帶領個案與治療師抵達個案核心的痛苦擔憂。理解個案有核心羞愧、焦慮不安全、悲傷孤單或這些的組合，有助於組織資訊、引導治療。 - 敘事：概念化也協助說出這些核心感受如何連結並影響個案的經驗、行為、思考與人際關係。這是個案與治療師之間、督導者與受督者之間的合作歷程。 - 原書示例（配套 DVD）：督導者提問：「這位個案的核心情緒基模，或核心傷口是什麼？」雙方合作討論，並試著協助個案抵達「如果我做自己，我就不會被接受」。這看起來是以羞愧為基礎、不被接受的核心組織，引導治療師接下來傾聽的方向。 - 標記也是通往核心的路：除了追隨痛苦，也要辨識能觸及痛苦及其來源的介入標記。例如出現自我批評或對重要他人的未解決感受的標記時，處理它們能幫助觸及核心的非適應性感受。

D4. 概念化的兩個階段、十一個步驟

階段一：展開敘事，觀察情緒處理風格（通常在前三次晤談）

1. 引導受督者同理回應，促進個案描述主訴：症狀、行為與關係困難。
2. 協助受督者在個案陳述問題時，傾聽鮮明與痛苦之處；督導者指出個案的非語言與語言訊號。
3. 協助受督者注意並觀察個案的情緒處理風格。
4. 協助受督者促進個案生命故事與敘事的展開，與認同和依附有關。

階段二：追隨個案的痛苦，並對個案的敘事有足夠理解（開始辨識核心情緒，共同建構焦點）

1. 辨識晤談中浮現的任務標記：它們是適合特定介入的機會。
2. 辨識個案底層的核心情緒基模，可能是適應性或非適應性的。
3. 辨識情緒中蘊含的需求。
4. 辨識遮蔽原發情緒的次發情緒。
5. 辨識個案通往核心情緒與自我組織的阻礙。
6. 與個案共同建構主題：個案如何對待自己、個案覺得自己如何對待他人、個案如何被他人對待。主題通常屬於個人內在或人際。有時還有存在性主題，例如失落、死亡、界線與選擇。
7. 督導者與受督者共同建構一個敘事，把主訴（關係與行為困難）與核心情緒基模連結起來，方法是討論個案在晤談中說了什麼、哪些感受似乎最核心。

時機（原教材）：

- 評估情緒處理風格與展開敘事，發生在治療關係的開始。
- 傾聽鮮明與痛苦早期就開始，並貫穿全程。
- 核心情緒的命名，要等到安全的同盟建立之後才進行。

- 把一切整合成主題與治療理由並建立焦點，發生在較後期，在短期治療（12–20 次）中大約是第四次晤談。
- 何時提供敘事：需要理由與焦點來強化合作時。例如個案主動詢問、對正在發生的事顯得困惑，或需要更清楚時。

總結：概念化從在治療關係形成的脈絡中解構主訴開始，走向辨識核心情緒基模與自我組織。

E. 介入技能的督導

E1. 三個面向

原教材指出，介入技能的督導聚焦於：

- 發展對改變歷程的理論理解；
- 發展敏銳的知覺技能；
- 逐步建立治療任務的能力。

對想學習特定介入的受訓者而言，督導的基礎是督導者告訴他們如何取得背景閱讀與對該治療理論的理論理解。EFT 督導者的首要任務之一，是把受督者引介到介入理論與既有研究。

E2. 情性知識與程序性知識

- 擁有概念知識，不等於擁有程序性知識，也不等於能在情境中使用它。智識上知道、需要時卻用不出來的知識，就是情性知識（Greenberg & Safran, 1986）。
- EFT 督導主要關心的不是傳遞概念知識以求智識理解，而是促進程序性學習：知道、並且能把理論理解表現在具體情境中，發展出親身認識的知識（knowledge by acquaintance）。
- 這一切是在建立「主動的知道如何做」：在特定情境、對特定個案，應用理論的介入模式。
- 在 EFT 的觀點中，治療師透過觀察、傾聽，並同理地回應個案而發展。

E3. 知覺技能

- 定義：看見正在發生什麼，並把它解讀為適合某種介入的機會的能力。
- 治療師學得最多的方式，是取用並標記（符號化）一位真實個案在治療中的經驗，然後在每次晤談中，以合作、平等的方式找出這些經驗的意義。
- EFT 督導因此聚焦於發展看、聽與同理的技能：察覺表達中非語言面向的瞬間變化、理解個案如何經驗事件，並辨識個案的微歷程，也就是晤談中處理經驗的各種方式。

E4. 三類歷程標記（Goldman & Greenberg, 2015）

類別	內容	督導方式
逐刻歷程微標記	語言：「抓住」個案語言內容的細微差異、鮮明度、個案的漫談；評估個案語言的具體性、特定性與生動性。非語言：猶豫、不一致的情感、聲音品質、喚起或經驗程度、痛苦	在錄影中當場指出

類別	內容	督導方式
特徵風格標記	個案通常如何對待自己與他人，通常要取得依附史的資訊。個案是自我批評、自我保護，還是自我貶抑？個案把他人看成遺棄的、迫害的，還是支持的？	調頻
主要任務標記	特定問題或痛苦心理狀態的標記，顯示個案準備好處理某個議題，並引導治療師提出特定任務與介入	辨識

此外，受督者需要學會區分原發適應性、原發非適應性、次發與工具性情緒（見單元1），並觀察個案的情緒處理風格。這是透過逐刻判斷，也就是歷程診斷（Greenberg, 2010），判斷個案如何處理情緒。需要觀察的重要歷程有四個：聲音品質、情緒喚起程度、經驗程度、該情緒的生產性。

E5. 個案的聲音品質

督導者可以協助受督者區分四種聲音品質。它們以一組聲音特徵為基礎，定義於一份個案聲音品質手冊（Rice & Kerr, 1986；Rice & Wagstaff, 1967），反映說話者當下注意力與能量的部署方式。督導者的做法，是在錄影中指出音高、能量程度、節奏與重音點等聲音特徵。

聲音品質	原教材的描述	臨床意涵（從臨床實務角度）
聚焦型	個案轉向內在，追蹤經驗，並試著把它符號化成語言	常是深化經驗的好時機
外化型	平穩、有節奏的語調，能量向外；有預先排練過、像演講的質地，缺乏自發性。雖然可能很有表現力，卻有「對著說」的感覺；內容不太可能是新鮮經驗到的	需要把個案帶回當下的經驗
受限型	不在正常音域，常顯得尖細，聲音背後有戒備，顯示情感被勒住，或許難以信任	先注意安全感與同盟
情緒型	說話時情緒突破而出進入聲音	情緒正在發生，需要調頻與涵容

E6. 個案的經驗程度

- 從一開始聽錄影，督導者就用經驗量表（Experiencing Scale），把受督者的注意力帶到個案經驗的深度。
- 經驗量表是受過訓練的 EFT 治療師使用的研究工具，但治療師坐在個案面前時並不即時編碼，因為那會干擾治療師的在場（Geller & Greenberg, 2011）與逐刻的同理調頻。治療師是受到對量表的理理解所引導，而這種理解常透過在其他治療示例與自己的錄影上練習使用量表而獲得。
- 當個案持續處在低經驗程度時，督導者會鼓勵受督者注意這點，提供更深的同理探索性反映與臆測，並觀察個案是轉向內在（例如「我覺得心裡好亂」），還是繼續向外（例如「你知道，我不知道他什麼時候會回家」）。

E7. 個案表達的情緒喚起

- 督導者可以用情緒喚起量表 (Warwar & Greenberg, 2000) 協助受督者理解情緒喚起。量表依據聲音與身體的喚起程度，以及表達受限的程度，評估個案情緒的品質與強度。
- 評估順序：受督者需要先評估該情緒是否為原發情緒，再評估其整體強度。
- 中等程度：聲音與身體的喚起中等，出現情緒型聲音；一般的說話模式被情緒溢出中度打斷，表現為重音模式改變、速度不均、音高改變；喚起可能仍有些受限。
- 最高程度：聲音與身體的喚起強烈而完整；一般的說話模式被情緒溢出完全打斷；喚起看起來無法控制、持續；有一種「崩解」的質地。
- 研究：Missirlian、Toukmanian、Warwar 與 Greenberg (2005) 顯示，中等程度的情緒喚起結合意義建構，而不是單純的高度喚起，可預測經驗性治療的正向結果。
- 注意：個案談論有意義、重大的事件或主題，卻沒有情緒喚起時，受督者需要注意，這表示需要探索身體感受到的經驗。

E8. 個案的情緒生產性

- 關鍵判斷：情緒被喚起之後，一個關鍵的評估是：個案是否以有生產性的方式處理這份情緒 (Ausra & Greenberg, 2008 ; Ausra, Greenberg, & Herrmann, 2013) 。這部分依據對經驗程度、喚起與聲音品質的評估，但也涉及對情緒表達本質的更高層次判斷。
- 一旦判斷所經驗的情緒是原發情緒，概念化就涉及判斷：這個被活化的原發情緒，是否以接觸性覺察的方式被處理。
- 七個向度：

向度	說明 (從臨床實務角度整理)
注意	注意力是否放在情緒上
符號化	是否能把經驗說成語言
一致性	表達是否與經驗一致
接納	是接納這份情緒，還是抗拒它
調節	喚起是否在可運作的範圍內
主體性 (相對於被動受害)	是否把自己經驗為能動者
分化 (相對於卡住)	情緒是否持續展開，而不是原地打轉

- 受督者個別或在團體中學習編碼錄影，以求熟練。個案可能在任一向度上有困難，這既顯示目前情緒處理的生產性如何，也指出需要處理的領域。
- 當所有生產性向度都達成時，情緒才被視為有生產性地被處理。

F. 治療任務的督導

F1. 標記與任務的研究基礎

- EFT 包含大量標記與治療任務 (Elliott et al., 2004 ; Greenberg, 2010, 2015 ; Greenberg, Rice, & Elliott, 1993) , 在督導中透過講解、觀察錄影與練習來教。
- 研究已經顯示, 個案會進入特定的問題情緒處理狀態, 這些狀態可由晤談中的陳述與行為辨識, 標示出底層的情感問題, 並提供特定類型有效介入的機會 (Greenberg et al., 1993 ; Greenberg, Elliott, & Lietaer, 1994 ; Rice & Greenberg, 1984) 。
- 個案標記不只指出要用哪一種介入, 也指出個案目前處理這個問題的準備度。
- 每一項任務都被 Greenberg 深入而廣泛地研究過, 解決路徑的關鍵成分與解決的具體形式都已被界定。因此, 實際改變歷程的模型, 是引導治療師介入的地圖。

F2. 七種主要標記與相應介入 (Greenberg et al., 1993)

標記	個案語句 (原書示例, 意譯)	介入	解決的樣貌
① 困惑反應: 對自己在特定情境的情緒或行為反應感到困惑	「來的路上看到一隻耳朵長長下垂的小狗, 突然好難過, 不知道為什麼。」	系統性喚起展開: 生動喚起經驗, 重新經驗情境與反應, 建立情境、想法與情緒反應之間的連結, 最後抵達讓反應變得合理的情境隱含意義	對自我功能的新看見
② 不清楚的體感: 個案停在表面, 或困惑、無法清楚感覺自己的經驗	「我就是有種感覺, 但不知道是什麼。」	澄心聚焦 (Gendlin, 1996) : 引導個案以注意力、好奇與願意經驗的態度, 接近經驗的身體面向, 並為身體感受找到字詞	身體感受的轉變與新意義的創造
③ 衝突分裂: 自我的一個面向對另一面向批評或強迫	一位女性在姊妹眼中失敗後, 很快感到無望、挫敗, 但也生氣: 「我覺得比她們差, 好像『我失敗了, 我沒她們好』。」	雙椅演出: 讓自我的兩部分彼此直接接觸; 探索並傳達每一部分的想法、感受與需求, 進行真正的對話	批評的聲音軟化, 兩邊整合

標記	個案語句（原書示例，意譯）	介入	解決的樣貌
④ 自我中斷分裂：自我的一部分中斷或壓縮情緒經驗與表達	「我感覺得到眼淚要上來，但我就是繃緊、吞回去，絕不要哭。」	雙椅演出：讓中斷的部分變得明確；個案覺察自己如何中斷，並被引導去演出中斷的方式，可能是身體上的（勒住或關掉聲音）、隱喻上的（關進籠子），或語言上的（「閉嘴、不要感覺、安靜、你撐不過去」）；讓個案經驗到自己是關閉歷程中的能動者，進而回應並挑戰中斷的部分	表達先前被阻擋的經驗
⑤ 未竟事務：以高度投入的方式，陳述對重要他人揮之不去的未解決感受	「我父親從來不在我身邊。我從沒原諒他。內心深處，我不覺得我在哀悼那些我大概從沒擁有、也知道永遠不會有的東西。」	空椅對話：個案活化自己內心的重要他人形象，經驗並探索自己對對方的情緒反應，並理解它們	對他人與自我的看法轉變；追究對方的責任，或理解、原諒對方
⑥ 脆弱：自我感到脆弱、耗竭、深深羞愧或不安全	「我覺得我什麼都沒有了。我完了。要我繼續撐下去太過分了。」	同理肯定的驗證：個案最需要治療師的同理調頻；不只捕捉內容，還要注意個案的生命力情感（vitality affects），映照經驗的節奏、韻律與語調；驗證並正常化這份經驗	自我感增強
⑦ 情緒痛苦與煎熬：通常發生在強烈的人際需求（例如愛或驗證）未被他人滿足時	—	慈悲的自我安撫：想像地重回被剝奪或不被驗證的場景，請個案在過去沒有撫慰的地方提供一些撫慰。方式是想像成年的自己進入被喚起的場景，給出修復性的回應；或進行對話，問個案作為成人，能否安撫受傷的孩子	喚起對自己的慈悲。自我慈悲與自我同理也會從調頻的治療師身上內化而來，但可能需要多年；請個案以成人的身分對受苦的自己提供慈悲，可以加快這個歷程

從臨床實務角度的提醒：上表只是「地圖」。原教材一再強調，標記同時代表準備度，所以「看到標記」不等於「立刻做任務」。單元4的例子也提到「這是未竟事務的標記，但現在回應還太早」。

F3. 任務督導的焦點

- 在錄影中辨識出個案標記之後，督導者與受督者一起釐清最適合這個標記的介入。
- 任務督導包括協助受督者處理特定任務、任務中的某個步驟，或流暢地融合多個任務上的困難。
- 原書示例（配套 DVD）：督導者引導受督者請個案演出母親（「好，那你真的當一次你媽媽。她怎麼讓你覺得她很需要人？是她臉上的表情嗎？」）；之後督導者指出，個案演出母親並說「我希望你當個很乖的孩子」時，聲音改變了。

- 原書示例（保持雙椅結構）：督導者指出治療師「失去了椅子」，對話變成一場討論，因而失去處理分裂的力量。督導者說明：這張椅子應該對另一張說出「沒希望了，結束吧，離開」，這會活化更多情緒；現在的對話卻在探索、分化衝突的各個面向，沒有表達批評來引發另一張椅子的情緒反應。督導者的建議是重新建立對話的兩邊，甚至讓衝突更尖銳，例如讓一邊對另一邊說「結束這段關係」，看看是否會有轉化。

F4. 原書的介入督導示例：教學重點

示例一：決策衝突（28 歲女性，猶豫是否換到國外的新工作）

時刻	督導者的重點
治療師只是複述「一方面好、一方面壞，很複雜」	你抓到了分裂，但需要更分化：清楚辨識兩個聲音，並把它們放進對話。兩個部分、兩個聲音各是什麼？（受督者：一邊說「去」，一邊說「我不太願意」）
個案自己開始用警告的聲音說話（「你會累的」）	很好，支持這個聲音
個案回嘴「別煩我，你很煩」	支持她的肯定，但此刻的目標不是讓她肯定自己，而是觸及她核心的痛苦情緒：焦慮不安全。最好先問：「你身體感覺到什麼？」
對話轉向一般性的「延後決定」	可以，但要再次讓兩邊清楚；跟隨她的線索（她彈手指，說「應該這樣」），請她換椅子，扮演那個驅策的部分
個案在被推的那一邊說「好累」	若能讓她更多地施壓會更好，因為她反覆說「怎麼辦」時很生動；強化壓力之後，再請她回到經驗的椅子，問她感受到什麼。可以加一句：「給她壓力。」

示例二：未竟事務（24 歲學生，第 12 次晤談；童年重要的阿姨與姨丈，在母親拒絕她之後又突然拒絕她）

時刻	督導者的重點
治療師從「很多愛」反映到「你也難過」	很好，你正從內容轉向她的情緒歷程
換椅子後，治療師問「身為阿姨，你聽到這些有什麼反應？」	這裡需要更具體的介入：要扮演負面的他人，喚起更痛苦的記憶與情緒。開放式提問常會引出對方想像中的辯護。最好的介入是：「身為阿姨，讓她覺得被不公平對待。對她不公平！」（受督者：我記得訓練時講過，但很難做到）
個案扮演的阿姨果然在辯護	「你看，她在辯護。」一開始就該這樣開始這一邊：目的是扮演負面的他人，喚起痛苦的記憶
個案說「我覺得這只是一種防衛」	這是自我中斷。問她內在感覺到什麼可以，但也可以用雙椅處理這個自我中斷

時刻	督導者的重點
個案說「我覺得平靜，像是我在處理這個情況」	這一切是保護性的歷程，保護她不去碰悲傷與憤怒的痛苦。這是一個重要的選擇點：看似調節，其實是為了逃避而調節。可以說：「我們換一下。你可以過來這裡嗎？我們把阿姨請出椅子，現在這是你的一部分。」
督導結尾的概念化	她需要哀悼她希望擁有的阿姨，才能放下未被滿足的需求。核心的非適應性感受是孤單被遺棄。解決的方式可能是先哀悼，再自我安撫，或表達肯定性（而非防衛性）的憤怒，進而轉化以悲傷為核心的情緒基模，把孤單與遺棄重組為對現在家庭的愛，以及對過去曾得到的愛的珍惜

示例三：理智化（53 歲女性，伴侶多年前因意外過世）

時刻	督導者的重點
治療師說「你說這個時很感動，對嗎？」「讓情緒在這裡」	很好，你保持聚焦在她的情緒
個案轉向「我需要一種強加給自己的行動模式」	要把她帶回她的哭泣或想哭的傾向。去找情緒並取得它的訊息，而不是進入更高層次的概念意義
個案談人生很沉重、不知何時有了這個故事	這些都比較哲學、抽象。你需要找到她核心的感受與需要。是什麼？（受督者：大概是悲傷）
治療師問伴侶的名字	很好，把它移向更具體的東西
治療師說「我不知道是悲傷還是遺憾」	很好，更清楚地聚焦於情緒

F5. 持續督導個案：焦慮的 26 歲女大學生

原教材以同一位個案的連續督導，示範督導如何隨治療推進。每次督導，督導者都先請受督者簡述晤談發生了什麼，詢問有沒有想處理的議題，再問希望督導者聚焦在什麼。雙方一起看了所有晤談錄影。

晤談	發生了什麼	督導重點
第 2 次	個案在大學諮商中心求助焦慮與憂鬱，與治療師連結良好，在中等經驗程度談話。她經驗他人是評判的，因此焦慮，在社交場合腦中一片空白、說不出話，然後又氣自己沉默	督導者以提問教學：「你怎麼理解？你聽到標記了嗎？」受督者辨識出焦慮分裂：一部分災難化並嚇唬另一部分（Greenberg, 2010）。督導者建議：從請個案在批評的椅子上演出評判的「他人」開始，常常最有喚起性，而不是從她自己的批評者開始
第 3 次	喚起了很多感受；批評者很嚴厲、很指責，讓她覺得自己渺小、軟弱，也為困在這個循環中感到悲傷	整體方向正確。雙方約定：若再出現焦慮工作的標記，要進一步分化批評者以揭露核心判斷，並讓批評更具體

晤談	發生了什麼	督導重點
第 4 次 (前段)	個案說自己的評判比預期他人的評判更痛。批評者嚴厲，但受督者無法協助她說出非常具體的批評；批評者說「我先貶低你，別人就不會」	督導者指出這偏向洞察，而不是演出。要讓批評者具體地演出批評，例如「昨天上課你問旁邊的人作業是什麼，你結結巴巴、很焦慮，出盡洋相」
第 4 次 (後段)	在「自我」的椅子上，個案觸及很多痛苦；治療師驗證了痛苦，但找不到字詞協助她分化感受、找出意義	雙方判斷核心的非適應性感受似乎是不被愛，但還不清楚是羞愧（「我有缺陷」）還是孤單被遺棄（「我無法獨自存活」）。督導者建議用混合式臆測，同時涵蓋羞愧與悲傷孤單，保持開放，直到最痛的感受變清楚。需求似乎是被驗證與親近。下次了解這些感受在原生家庭中如何形成
第 4 次 (背景)	個案是獨生女。父親情緒起伏大、常表達憤怒，有一次追她，她在最後一刻跑進房間鎖門，非常害怕；父親對她說過很刻薄的話，明顯是情緒虐待。母親通常忽略父親；有一次母親被父親打，還叫女兒「別小題大作」。父母從沒來過她的表演或學校活動，她覺得自己不被想要。現在與父母疏遠	督導者判斷，未竟事務可能是焦點；依據出現的標記，與父親的未竟事務可能最核心
第 5 次	個案談到難以面對男友的過去感情，這喚起不被愛、不是對方最重要的人的恐懼與悲傷，她自己連結到父親。治療師開始與父親的空椅對話。她經驗並表達悲傷、孤立與孤單，自由地哭泣，說出自己多麼孤單、不被想要	督導者注意到一個小轉變：她以更內在聚焦的聲音說「對他來說已經太遲了」
第 5 次 (憤怒)	個案表達失望，說父親沒有藉口，然後有點生氣。受督者問是否要強化她的憤怒	督導者指出：表達憤怒很重要，但她目前的憤怒偏拒斥性或破壞性，是一種「說教」的聲音（「你是個壞爸爸，太自私、太懦弱」）。在一定程度的外向憤怒之後，要引導她表達更賦能的憤怒，使用「我」的語言：「我對你很生氣」「我很憤怒你這樣做」。這能讓她把注意力放在自己的感受上，而不是對父親的負面評價
第 5 次 (尾聲)	她追究父親沒有與她保持聯繫，說不是因為自己不可愛，而是他沒有愛的能力；她想要孩子，打破壞童年的循環。但接著懷疑自己是否有權生氣、未來是否有權快樂。受督者不知道怎麼做，只是同理	督導者指出這是自我中斷的標記，可以用自我中斷的雙椅演出處理：一邊作為主動的能動者，阻止另一邊感到憤怒，甚至阻止她擁有快樂的權利。這能幫助她觸及被阻擋的憤怒，以及快樂的權利

從臨床實務角度的倫理提醒：這個個案包含童年情緒虐待與家庭暴力的揭露。原書是以督導示例呈現，重點在情緒工作。在實務中，受督者也應同時留意目前的安全、法定通報義務（若涉及仍處於危險中的未成年人），以及深化創傷記憶前的穩定度。這些屬於一般臨床實務要求，不是原書本章討論的內容。

F6. 本章結論

原教材指出，督導者與受督者之間好的督導同盟，是督導的必要條件（sine qua non）。同盟建立之後，焦點轉向督導受督者的在場、無條件正向關懷、真誠與同理，以及與個案形成同盟的人際技能，同時持續關注同盟隨時間的維持。第4章會提供促進這些技能的督導示例。

G. 理論架構：本章的整合模型

層次	督導者協助受督者……	關鍵工具
關係	建立並維持督導同盟與治療同盟	Bordin 三成分；「先接觸，再訂契約」
存在	在場、同理調頻	同理理解 → 探索性同理 → 同理臆測；最多領先一步
知覺	聽見聲音、看見微標記、判斷生產性	聲音品質 4 型；經驗量表；喚起量表；生產性 7 向度
概念化	追隨痛苦，抵達核心自我組織	痛苦羅盤；兩階段 11 步驟；3 種核心組織
介入	在標記出現時進入任務、守住結構	7 種標記與任務；任務中的步驟與融合

從臨床實務角度：這五層是同時運作的。例如，判斷「現在可以做空椅嗎？」需要同盟（關係）、個案是否準備好（知覺）、這是不是核心議題（概念化），以及知道如何開始（介入）。

H. 實證基礎

主張	證據性質	強度與限制
同盟三成分（Bordin）	理論模式，廣泛用於同盟研究	本章引用為框架，未討論具體研究
受好評的督導者特質	Falender & Shafranske（2004）的整理	屬於文獻回顧與專業共識
在場是調頻的前提	Geller & Greenberg（2011）	理論與臨床整合；本章未說明實證細節
個案標記代表特定的問題狀態與準備度	Greenberg 等（1993）；Rice & Greenberg（1984）等任務分析研究	有歷程研究基礎；本章未說明樣本與方法
中等喚起 + 意義建構可預測結果	Missirlian 等（2005）	相關性研究，不能直接推論因果；原書未說明樣本

主張	證據性質	強度與限制
情緒生產性	Auszra 等 (2013) 發展的評估架構	研究工具；本章未提供信效度資料
各任務的解決路徑已被界定	Greenberg (2010, 2015) 的任務分析	屬於歷程研究；介入的「必要性」仍需以個案反應檢驗
督導示例	真實督導錄影 (已改寫)	是示範，不是效果證據

I. 臨床意義

面向	本單元的意涵
評估	歷程診斷的四個觀察向度：聲音、經驗、喚起、生產性；三類標記
概念化	追隨痛苦，而不是推論人格或防衛；核心組織要以現象學經驗為依據；命名核心情緒要等同盟穩固
治療計畫	標記引導任務，也代表準備度；約第四次晤談形成焦點（短期治療）
治療關係	目標共識是捕捉長期痛苦，而不是設定行為目標；同理理解提供安全
介入	同理類型依時機選擇；最多領先一步；守住任務結構
監控	看個案對回應的反應：轉向內在、聲音轉為聚焦、情緒分化
督導	以錄影逐刻教學；以提問教學；受督者學習編碼錄影

J. 臨床推理：一名臨床心理師看到這些資料時如何思考

以「個案在空椅對話中，開始用說教的語氣批評父親」為例：

- 應蒐集的資訊：聲音品質（外化、說教？）；憤怒是用「你」還是「我」表達？經驗程度；目前處於對話的哪個階段？
- 可能的假設：
- 拒斥性憤怒：評價對方，距離自己的原發經驗較遠；
- 原發的賦能憤怒，但還沒被「我」語言符號化；
- 次發憤怒遮蔽悲傷。
- 替代解釋：若父親曾有虐待行為，憤怒可能是適應性的界線回應（原書第5章的區分，見單元5）。
- 支持或削弱各假設的資料：
- 引導改用「我」語言之後，聲音是否更聚焦、更有力量？
- 個案說出憤怒後，是更清楚，還是更卡住？

10. 下一步：在一定程度外向憤怒之後，引導個案說「我對你很生氣，因為……」；並注意憤怒之後是否浮現悲傷與需求。

K. 常見誤解與臨床陷阱

1. 只用探索性同理，缺乏同理理解。個案會感到被推著走。
2. 領先兩步：過早引出個案還沒有的情緒。
3. 在個案說出核心字眼（例如「被剝奪」）時，讓他滑回意義敘事。
4. 用人格、防衛或關係模式做 EFT 概念化，而不是追隨痛苦。
5. 太早命名核心情緒，在同盟穩固之前就說出來。
6. 把概念知識當成能力（情性知識）。
7. 在晤談中即時對量表評分，失去在場。
8. 把高喚起當成目標。研究支持的是中等喚起加意義建構。
9. 看到標記就立刻做任務，忽略準備度。
10. 雙椅對話滑成討論，失去兩張椅子的接觸。
11. 空椅中用開放提問請個案扮演對方，引出對方的辯護，而不是負面經驗。
12. 把「平靜」一概視為好的調節，沒有看出是為了逃避而調節。
13. 理智化的個案被帶進更抽象的意義討論。
14. 強化拒斥性憤怒，而不是引導為「我」語言的賦能憤怒。
15. 把「懷疑自己有權生氣」只當作內容回應，沒看出這是自我中斷的標記。

L. 倫理、文化與專業考量

- 督導者對同盟負主要責任，並透過同盟讓回饋不致羞辱受督者。
- 錄影與編碼練習需要個案的知情同意，並遵守保存規範（從臨床實務角度）。
- 創傷與虐待揭露：深化情緒工作的前提是安全的同盟與穩定度；涉及未成年人仍處於危險時，須依法通報（從臨床實務角度）。
- 文化（從臨床實務角度）：聲音品質與喚起的表現有文化與個人差異。例如某些文化中，較低的外顯喚起不代表經驗淺。評估時應以個案自身的基準線為參照。
- 個案的依附史（特徵風格標記）涉及敏感資訊，蒐集時應在同盟中逐步進行。

M. 學習者必須帶走的核心知識

層次	內容
必須記住	同盟三成分；5 種同理回應；3 種核心自我組織；概念化 2 階段 11 步驟；3 類歷程標記；4 個觀察向度；4 種聲音品質；生產性 7 向度；7 種標記與任務
應該理解	在場為何是調頻的前提；最多領先一步；痛苦羅盤與現象學依據；情性知識 vs. 程序性知識；中等喚起加意義建構；標記代表準備度

層次	內容
能夠應用	依時機選擇同理類型；在片段中辨識聲音品質與標記；守住雙椅與空椅的結構；把拒斥性憤怒轉為「我」語言；隨新資料更新概念化
能夠批判性思考	相關性研究的限度；「不描繪人格」的概念化在跨專業場域的限制；文化對聲音與喚起的影響；示例不等於效果證據

§3 核心概念洞見

洞見一：好的同盟，讓矯正性回饋不再羞辱人

- 核心命題：督導同盟由連結、目標共識與任務關聯組成；它是安全基地，讓受督者能接受替代性的回應建議，而不覺得被羞辱。
- 臨床重要性：EFT 督導有大量逐刻的技術回饋。沒有同盟，這些回饋會變成威脅。
- 對臨床推理的影響：受督者對回饋出現防衛或順從時，先檢查同盟，而不是加重回饋。
- 例子：受督者在一次督導中被指出十個可以更好的地方，卻仍然感到被支持，因為督導者先肯定了他做對的地方，並以「可以更貼近」的語氣說明。
- 常見學生誤解：以為同盟就是「督導者人很好」。同盟還包括目標共識與任務關聯。
- 教學重點：同盟是回饋能被吸收的條件。

洞見二：同理有很多種，時機決定用哪一種

- 核心命題：同理理解提供安全；探索性回應聚焦前緣、使內隱變外顯；同理臆測來自治療師的參照架構，特別適合理智化的個案。所有回應都要在近側發展區內，最多領先一步。
- 臨床重要性：只會一種同理的治療師，要不是陪著繞圈子，就是推得太快。
- 對臨床推理的影響：每次回應前問自己：「個案現在需要被理解，還是準備好往前一步？」
- 例子：個案說「我覺得……被剝奪了，但我覺得……」，正要滑回解釋。此刻用一句簡短的「就是被剝奪」把他留住，比再給一個長的理解性反映更有幫助。
- 常見學生誤解：以為越深的回應越好。領先兩步會讓個案跟不上。
- 教學重點：貼近個案所在之處，最多領先一步。

洞見三：跟著痛苦羅盤走，不要先畫地圖

- 核心命題：EFT 概念化從情緒痛苦出發，依據現象學經驗，逐步抵達核心自我組織（羞愧、焦慮不安全、悲傷孤單），而不是一開始就推論人格或防衛。
- 臨床重要性：太早下定論的概念化，會讓治療師只聽見符合假設的資料。
- 對臨床推理的影響：概念化是暫定的、共構的，而且要等同盟穩固才命名核心情緒；不確定時用混合式臆測保持開放。

- 例子：原書的持續個案中，第四次晤談時督導者還無法確定核心是羞愧還是孤單被遺棄，於是建議同時涵蓋兩者的臆測，直到最痛的感受變清楚。
- 常見學生誤解：以為好的概念化要在初談後就完成。
- 教學重點：在抵達之前，我們無法說出核心是什麼。

洞見四：看見和聽見，是可以被訓練的

- 核心命題：知覺技能透過具體工具訓練：聲音品質 4 型、經驗量表、情緒喚起量表、情緒生產性 7 向度。這些工具培養敏感度，但晤談中不即時評分。
- 臨床重要性：這讓「臨床直覺」變成可以教、可以練的技能，而不是天分。
- 對臨床推理的影響：個案談重大事件卻毫無喚起，要探索身體感受；喚起很高但沒有意義建構，也不一定有助。
- 例子：受督者學會分辨：個案平穩、有節奏地重述事件，是外化型聲音；說到一半停下來、找字詞，則是聚焦型聲音。後者往往是深化的時機。
- 常見學生誤解：以為情緒越強烈越好。原書引用的研究支持的是中等喚起加上意義建構。
- 教學重點：把「看見」與「聽見」變成可以練習的技能。

洞見五：標記是地圖，但走路的是個案

- 核心命題：七種任務標記各有相應的介入與解決路徑，但標記同時代表準備度；任務中要守住結構：雙椅不滑成討論，空椅扮演負面他人，辨識為逃避而調節，並把拒斥性憤怒轉為「我」語言。
- 臨床重要性：技術的細節決定任務能不能帶來轉化。
- 對臨床推理的影響：在任務中持續問：「此刻的對話是在經驗，還是在討論？是在接近痛苦，還是在保護自己不去碰它？」
- 例子：空椅中間個案「身為阿姨，你有什麼反應？」，結果引出阿姨的辯護；改成「讓她覺得被不公平對待」，才喚起了痛苦。
- 常見學生誤解：以為知道任務的步驟就夠了。原書的督導大多在處理步驟中的微小選擇。
- 教學重點：任務的力量在細節裡：守住結構，並跟隨個案的線索。

§4 關鍵原文引述

引述一

原文：

“Knowledge in which one knows something intellectually but cannot use it when needed is inert knowledge”

中文意譯：「智識上知道、需要時卻用不出來的知識，就是惰性知識。」

出處：Greenberg & Tomescu (2017), Chapter 3, Supervision of Intervention Skills, p. 58 (引 Greenberg & Safran, 1986)。

臨床意義：這句話說明為什麼 EFT 督導以錄影和練習為主，而不是講授理論。臨床能力是程序性的：在特定時刻、對特定個案，知道如何做。

教學意義：碩士生常以為讀懂教科書就準備好了。這句話提醒我們：能否在晤談中「用出來」，要透過在具體片段中被指出、練習、再嘗試來培養。

引述二

原文：

“The [client’s] pain is like a compass and it’ll lead you to whatever is [at the] core.”

中文意譯：「個案的痛苦就像一個羅盤，它會帶你到核心所在。」

出處：Greenberg & Tomescu (2017), Chapter 3, Supervision of Case Formulation, pp. 54–55 (督導示例中的督導者語句，原文有編者補字)。

臨床意義：這是 EFT 概念化最精煉的表述：不從理論推論開始，而是跟隨個案表達痛苦的方式，逐步抵達核心自我組織。

教學意義：概念化不是一開始就要交出的答案，而是跟隨的方向。受督者可以練習在錄影中找出「最觸動的時刻」，把它當作羅盤指的方向。

引述三

原文：

“A good supervisory alliance between the supervisor and supervisee is the sine qua non of supervision.”

中文意譯：「督導者與受督者之間良好的督導同盟，是督導的必要條件。」

出處：Greenberg & Tomescu (2017), Chapter 3, Conclusion, p. 79.

臨床意義：本章大量篇幅在講技術，但結論回到同盟。這與治療平行：技術只有在安全的關係中才能發揮作用。

教學意義：受督者若在督導中感到不安全，這本身就是需要處理的議題，而不是忍著繼續學技術。單元4會說明如何辨識並修復督導同盟的裂痕。

§5 臨床推理框架

5.1 晤談中的逐刻推理：此刻該怎麼回應？

步驟	問題	本單元的具體做法
① 我現在知道什麼？	可觀察的資料	個案的話語（具體或抽象？）；聲音品質（聚焦、外化、受限、情緒）；非語言微標記（猶豫、敲手指、嘆氣）；喚起程度
② 我還不知道什麼？		這是原發情緒嗎？個案準備好了嗎？同盟夠穩嗎？
③ 我正在形成什麼假設？	歷程診斷	經驗程度高或低？情緒生產性的哪個向度卡住？有沒有任務標記？
④ 有哪些替代解釋？		例如「平靜」是調節，還是為了逃避而調節？「生氣」是賦能的，還是拒斥的？
⑤ 什麼資料可以支持或推翻？		以一句回應測試，看個案是轉向內在，還是轉向外在
⑥ 下一步應該做什麼？	選擇回應	同理理解（安全）、探索性回應（前緣）、同理臆測（理智化時）、任務（標記出現且準備好時）
⑦ 哪些因素可能改變我的判斷？		個案的反應；新的風險資訊；同盟的變化
⑧ 如何轉化成臨床決策？		最多領先一步；守住任務結構；把拒斥性憤怒引導為「我」語言

5.2 概念化推理：追隨痛苦羅盤

問題	階段	對應步驟
個案的主訴是什麼？哪裡最觸動、最痛？	階段一（前三次晤談）	步驟 1–2
個案怎麼處理情緒？生命故事如何展開？	階段一	步驟 3–4
出現了哪些任務標記？核心基模是什麼？	階段二	步驟 5–6
情緒中的需求是什麼？哪些次發情緒遮蔽了原發？	階段二	步驟 7–8
什麼阻礙了個案觸及核心？	階段二	步驟 9
主題是什麼（對己、對人、被對待；存在）？	階段二	步驟 10
如何把主訴連結到核心基模，形成敘事？	階段二（約第 4 次晤談）	步驟 11

核心組織的區辨線索（從臨床實務角度）：

核心組織	常見的個案語句	常見的需求
羞愧	「如果我做自己，就不會被接受」「我有缺陷」	被接納、被重視
焦慮不安全	「我沒辦法一個人」「我撐不住」	安全、支持
悲傷的孤單被遺棄	「沒有人」「我不被想要」	親近、連結

不確定時：用混合式臆測涵蓋多種可能，讓個案的反應告訴你哪一個最貼切。

5.3 任務推理：標記 → 準備度 → 介入 → 結構

問題	做法
這是哪一種標記？	對照七種標記與個案語句
個案準備好了嗎？	同盟、穩定度、經驗程度、晤談時間
介入是什麼？解決長什麼樣子？	依表 F2
任務進行中，結構還在嗎？	雙椅：兩邊清楚、有接觸、衝突夠尖銳？空椅：先扮演負面他人喚起經驗？
出現了新的標記嗎？	例如空椅中出現自我中斷，改做自我中斷的雙椅
情緒是賦能的，還是拒斥的？是調節，還是逃避？	必要時引導為「我」語言；辨識為逃避而調節

5.4 督導推理：受督者需要學什麼？

層次	督導問題	督導者的做法
同盟	受督者能接受回饋嗎？	先肯定，再「可以更貼近」
存在	受督者在場嗎？	協助受督者看見非語言訊息
知覺	受督者聽見聲音的變化了嗎？	在錄影中暫停並指出；練習編碼
概念化	受督者在追隨痛苦嗎？	問：「你最被什麼觸動？核心傷口是什麼？」
介入	受督者知道下一步嗎？	以提問教學；示範語句；說明原理